

Pasuruan, 17 Maret 2026

Nomor : 238/RSPHS/I-UND/DIR/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan RCA Investigasi Komprehensive

Kepada Yth.
Staf Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo (terlampir)
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (Sentinel Event) pada tanggal 18 Maret 2026 terkait kejadian tidak diharapkan yang serius pada pasien **Ny. Marchetta Acyntia Pramesti / 20 thn (RM:134225)** pada tanggal 07 Maret 2026. Dengan kehamilan pertama, belum pernah melahirkan, tidak ada riwayat abortus/keguguran, usia kehamilan sekitar 34–35 minggu dengan diagnosa akhir adalah Post SC + ILO, Kami akan melakukan RCA pada:

Hari / tanggal : Rabu, 18 Maret 2026
Pukul : 11.00 - Selesai
Tempat : Ruang Meeting Kantor Sekretariat dan Zoom Meeting
Link Zoom : Menyusul

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka **wajib** untuk hadir. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Komite PMKP



Lidia Puspita Kencana, S.K.M.

LAMPIRAN

Nomor

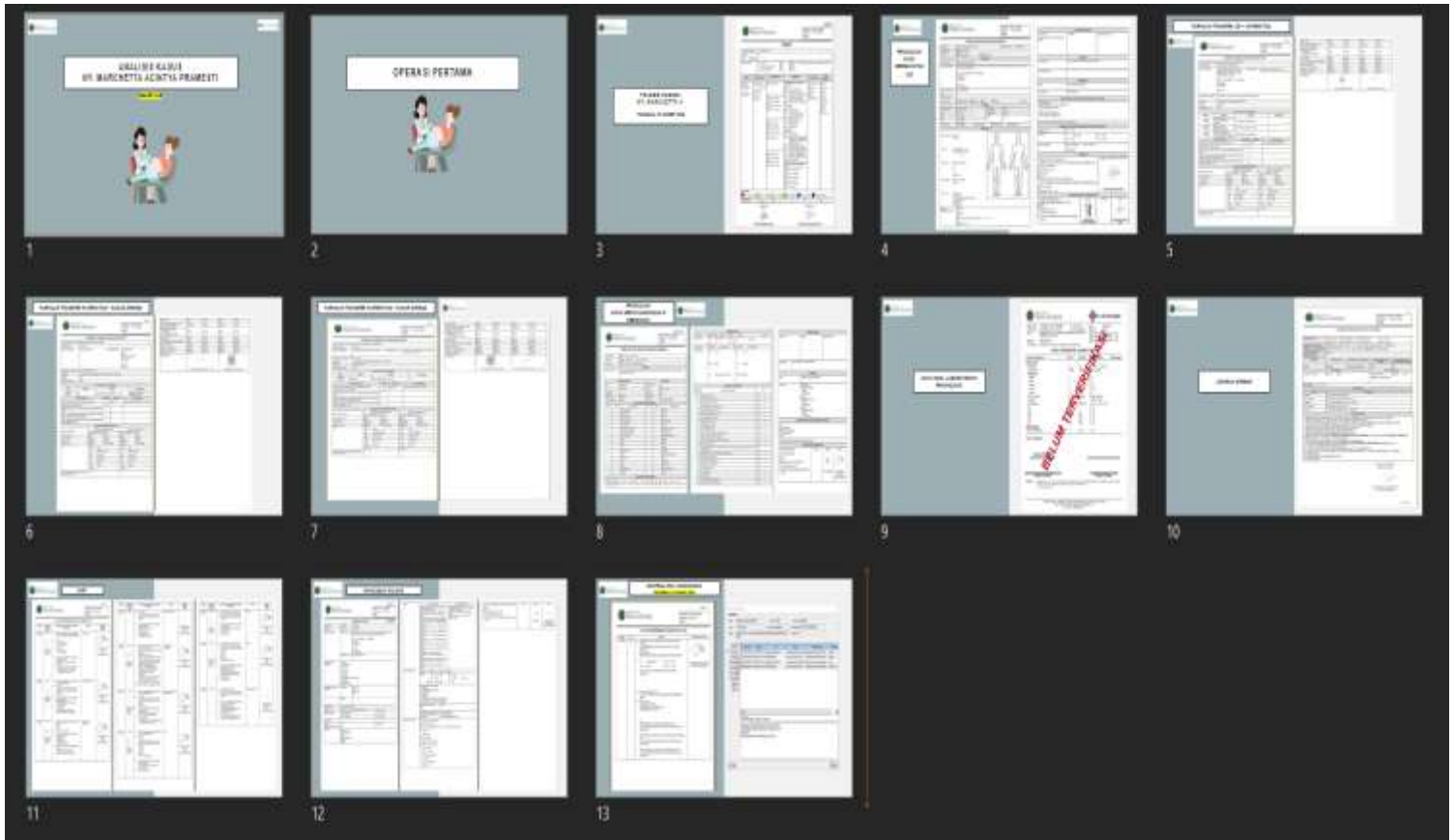
: 238/RSPHS/I-UND/DIR/III/2026

Perihal

: Undangan RCA

No	Nama	Jabatan
1	Dr. dr. Aslichah M.Kes., AFP., CHAE	Manajer Mutu & Pelayanan PT Disa Prima Medika
2	Sisca Puspitasari S.Kep., Ns	Kabid Pelayanan
3	Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Kabid Penunjang & Komite Keperawatan
4	dr. Ferry Limantara, Sp.EM	Kainst IGD
5	dr. Mohammad Ilyas Febri	Dokter IGD
6	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	Dokter Spesialis Obgyn
7	dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS	Dokter Spesialis Patologi Klinik
8	Lidia Puspita Kencana, S.K.M	Komite PMKP
9	Novia Ainur Pratiwi, S.KM	Kepala SDM & Diklat
10	Tamara Putri S.Psi	SDM
11	Nurul Karima, A.Md.Kep	PLT. Karu IGD
12	Iga Octanesya, S.Kep., Ns	Perawat IDG
131	Rizky Dwi Ramadhani, Amd.Kep	Kepala Ruang IKO
4	dr. Bobby	Dokter Spesialis Anastesi
15	Rohman	Asisten dokter anastesi
16	Muhammad Wafi Taufiq, S.Kep., Ns	Perawat IKO
17	fendra	Perawat IKO
18	Danang	Perawat IKO
19	Permata Sari Pratiwi, S.Farm., Apt	Farmasi
20	Shinta Aprilia Rizky Wulandari S.Farm. Apt	Farmasi
21	Ninis Indrawati, S.Tr. Keb.	Kepala Ruang Maternitas
22	Novita Wulansari, A.Md.Keb	Bidan
23	Nurul Komariyah, Amd. Keb	Bidan
24	Izzaty	Amalia

MATERI



ABSENSI
DAFTAR HADIR
Rapat Audit kasus NY. Marchetta Acyntia Pramesti

Daftar Hadir
RAPAT AUDIT KASUS NY. MARCHETTA

Tempat : UNIT MASIING - MASIING (MEDIA ZOOM)
Location

Tanggal dan Jam : 18 MARET 2026
Date Time
Jam : Pkl. 11.00 WIB
Time



RSPHSKR
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir
RAPAT FEBRUARI 2026 - PPRA dan FARMASI

Tempat : R.FARMASI
Location

Tanggal dan : Rabu, 2026-02-11 14:00:00
Date Time
Jam : Wed, 2026-02-11 14:00:00
Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi		
2	apt. Permata Sari Pratiwi, S.Farm	Farmasi	Apoteker		
3	apt. Permata Sari Pratiwi, S.Farm	Farmasi	Apoteker		
4	apt AVIVATUL KHOIROH, S.Farm	Farmasi ppra	Apoteker		
5	lilis ika kurniawati	farmasi	apoteker		
6	Dita Nurul Aini, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
7	Dita Nurul Aini, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
8	Dita Nurul Aini, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
9	Yolanda Riskawasianda Yuniavirsa, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
10	Yolanda Riskawasianda Yuniavirsa, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
11	Miftakhul Rohmah Putri, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
12	Miftakhul Rohmah Putri, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
13	Apt Ramadhan Rizki P	RSPHSKR	Farmasi		
14	Apt Ramadhan Rizki P	RSPHSKR	Farmasi		
15	Apt Ramadhan Rizki P	RSPHSKR	Farmasi		

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
16	Dita Nurul Aini, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
17	Dita Nurul Aini, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
18	lilis ika kurniawati	farmasi	apoteker		
19	Miftakhul Rohmah Putri, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
20	Chela Meidita Elsa Putri	Farmasi	PELAKSANA		
21	Chessia Jeseloy Cahya Putri A. Md. Farm	Farmasi	PESERTA		
22	Khoirun najwa abidah (najwa)	Farmasi	PESERTA		
23	Khoirun najwa abidah (najwa)	Farmasi	PESERTA		
24	Fadiya Ayu Diah Hermawati A. Md. Farm	Farmasi	PESERTA		
25	Fadiya Ayu Diah Hermawati A. Md. Farm	Farmasi	PESERTA		
26	Della Anasya Nandita, A.Md.Farm	Tenaga Vokasi Farmasi	PESERTA		
27	Shofiyah Nisrina Dewi, A.Md.Farm	Farmasi	PESERTA		
28	apt AVIVATUL KHOIROH, S.Farm	Farmasi	Ppra		
29	apt AVIVATUL KHOIROH, S.Farm	Farmasi	Ppra		
30	apt AVIVATUL KHOIROH, S.Farm	Farmasi	Ppra		

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Rabu, 18 Maret 2026
 PUKUL : 11.00 - selesai
 AGENDA RAPAT : Rapat Studi Kasus Pasien ny. Marchetta

PEMIMPIN RAPAT : Dr. dr. Aslichah. M.Kes. AFP., CHAE.
 NOTULIS : Ns. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.
 TEMPAT : Ruang Meeting Sekretariat Lt.

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Pengkajian awal perawatan IGD pada operasi pertama	1. GCS sudah tertulis E4V5M6 dan sudah tertulis total jumlah GCS tertulis 15 2. Diagnosa awal pasien di igd adalah G1P0A0, GA 34+2 minggu, PPR0M. 3. Pengkajian awal pasien sudah lengkap 4. Penulisan pemberian obat sesuai dengan rute dan dosis	1. format penulisan GCS : E...V...M... sudah baik, dari kasus sebelum terupdatenya simrs 2. PROM (Preterm Premature Rupture of Membranes) = ketuban pecah sebelum persalinan dan sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pengambilan diagnosa keperawatan sesuaikan dengan priotritas klinis pasien 3. Pengkajian pada pasien meliputi keluhan pasien saat ini, riwayat pengobatan, riwayat penyakit terdahulu, riwayat operasi sebelumnya. Pengkajian wajib dilakukan penulisan sesuai dengan kondisi pasien pada saat masuk rawat inap 4. Penulisan dosis dan rute wajib disesuaikan dengan penggunaan.	Programmer IT, Ka IGD, Kabid Pelayanan Perawat IGD Ka. IGD Kabid Pelayanan, Komite Keperawatan Ka IGD, Kabid Pelayanan, Komite Keperawatan

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
		6. RPO pasien sudah terkaji	6. Pengkajian pasien wajib meliputi RPO pasien dengan dokter jaga, DPJP serta farmasi terkait penggunaan obat-obatan pasien sebelumnya (yakni tergalil hanya penggunaan obat <u>suplemen kehamilan</u> .	SDM & Diklat, Kabid Penunjang, Ka. IGD Ka. IGD, Perawat IGD
2.	Penggunaan antibiotik	1. Belum terkaji penggunaan antibiotik pasien sebelum MRS 2. Penggunaan antibiotik pre-op dan pasca op sudah sesuai dengan pedoman PPRA 3. Penggunaan <i>double</i> antibiotik apakah sudah terkaji oleh apoteker di ruangan?	1. Dokter IGD, perawat serta apoteker wajib melakukan pengkajian ulang kepada pasien terkait penggunaan obat-obatan sebelumnya dan saling berkoordinasi dengan PPJA 2. Penggunaan antibiotik Cefazoline merupakan antibiotik profilaksis yang sangat sering digunakan, terutama untuk pencegahan infeksi pada tindakan operasi. Pada kasus pasien ini profilaksis yang diberikan sudah sesuai dengan PPAB (Pedoman Pemberian Antibiotik) profilaksis dimana untuk SMF Obstetri dan Ginekologi menggunakan profilaksis antibiotik cefazolin Cefazolin 2 gram IVFD diberikan 30–60 menit sebelum insisi operasi. 3. Sudah dilakukan pengkajian penggunaan antibiotik di ruangan maternitas oleh apoteker serta pasien tidak mendapat antibiotik selama berada di ruang rawat inap maternita	TIM PPRA, Apoteker unit, dan Kabid Penunjang
4.	Catatan perkembangan pasien terintegrasi	Diagnosa keperawatan nyeri muncul tetapi tidak ada pengkajian PQRST	1. Setiap pengkajian nyeri dapat mencantumkan PQRST di data subjektif	All Perawat All Perawat Karu RM
5.	Waktu tunggu pasien di IGD	Waktu tunggu dan transfer pasien ke rawat inap pada MRS sudah sesuai	1. Waktu tunggu pasien dari igd ke ruang unit rawat inap sesuai	, Perawat IGD, Dokter Jaga IGD
6.	Laporan operasi	Laporan operasi sudah lengkap Penandaan tempat operasi	Penulisan laporan operasi sudah sesuai menggunakan, 1. Pengisian laporan operasi wajib di lengkapi sesuai dengan kondisi pasien 2. Evaluasi dan audit rekam medis	Perawat IKO, DPJP
8.	Transfer unit	Tanda-tanda vital pasien di IGD dan saat dilakukan transfer unit sama.	Setiap pasien yang akan di transfer ke IKO, IRNA, ICU, Maternitas, NICU dilakukan pemeriksaan ulang dan lakukan pendokumentasian pada ERM sesuai kondisi pasien terbaru	Perawat dan Bidan all Unit



9.	Kontrol poli	1. Pasien mengeluhkan nyeri pada area luka operasi. Luka tampak merembes cairan berwarna kuning yang mengarah pada kemungkinan infeksi luka operasi. 2. Kebersihan luka kurang terjaga karena pasien jarang mandi dan kurang memperhatikan perawatan luka di rumah. 3. Pasien kurang bergerak/mobilisasi sehingga berisiko memperlambat penyembuhan luka dan meningkatkan risiko komplikasi pasca operasi. 4. Pasien melakukan pantangan makan ("tarak") sehingga asupan nutrisi tidak optimal untuk proses penyembuhan luka. 5. Terdapat faktor risiko infeksi berupa luka merembes, kebersihan diri kurang, mobilisasi kurang, dan status nutrisi yang tidak adekuat.	1. Dilakukan pemeriksaan luka oleh dokter, pembersihan luka sesuai prosedur, edukasi tanda bahaya infeksi, serta pemberian terapi sesuai indikasi medis. 2. Edukasi pasien dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, mandi secara teratur, menjaga luka tetap bersih dan kering, serta melakukan kontrol sesuai jadwal. 3. Edukasi mengenai mobilisasi dini dan aktivitas fisik ringan secara bertahap sesuai toleransi pasien untuk mempercepat proses pemulihan. 4. Konseling gizi mengenai pentingnya konsumsi makanan tinggi protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung penyembuhan luka. Meluruskan persepsi yang keliru terkait pantangan makanan pasca operasi. 5. Pemantauan berkala kondisi luka, KIE obat pulang dari poli dan memberikan informasi penggunaan antibiotik secara bijak kepada pasien.	Perawat poli, DPJP, Apoteker
----	--------------	---	--	---------------------------------

Pemimpin Rapat

(Dr. dr. Aslichah. M.Kes. AFP., CHAE)

Pasuruan, 18 Maret 2026

Notulis

(Ns. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.)

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.